

1. Информация об индикаторе	
Цель	Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
Задача	К 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и тропических болезней, которым не уделяется должного внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями
Индикатор	Заболеваемость туберкулезом на 100 000 человек
2. Информация об организации	
Организация	Министерство здравоохранения Республики Казахстан
3. Определения и понятия	
Определение	Показатель заболеваемости туберкулезом на 100 000 человек определяется как оцененное количество новых или вновь заболевших туберкулезом (учитываются все формы туберкулеза, в том числе у людей, болеющих СПИДом), возникших в данном году, в расчете на 100 000 населения.
Основные понятия:	Для прямого измерения требуются высококачественные системы наблюдения, которые имеют низкий уровень недооценки, и качественная система здравоохранения, для того, чтобы вероятность недооценки диагноза также была минимальна. В противном случае косвенные оценки будут основаны на данных о регистрации и оценках уровня недоучета и недооценки диагноза.
Обоснование и толкование	После двух лет консультаций в мае 2015 года Всемирной ассамблеей здравоохранения была одобрена новая Глобальная стратегия борьбы с туберкулезом после 2015 года. Известная как Конечная стратегия туберкулеза, она охватывает период 2016-2035 годы. Общая цель стратегии - «Окончить глобальную эпидемию туберкулеза», и соответственно, в контексте ЦУР, были установлены амбициозные цели по сокращению случаев заболеваний и смертности от туберкулеза для 2030 года (снижение уровня заболеваемости на 80% по сравнению с 2015 годом) и для 2035 года (снижение уровня заболеваемости на 90%). Показатель Уровень заболеваемости туберкулезом был выбран для измерения сокращения числа случаев заболеваемости туберкулезом. Несмотря на то, что данный показатель в большинстве стран был оценен в 2014 году с высоким уровнем неопределённости, национальные власти предоставляют хороший прокси показатель (заменитель) для случаев, когда имеет место ограниченное занижение выявленных случаев заболевания или ограниченные недооценка или переоценка случаев диагноза.
4. Источники данных и методы сбора	
Источники данных	Административные данные
Методы сбора данных	Данные поступают из административного источника, доступны на ежегодной основе
Единица измерения	На 100 000 человек
Периодичность	Ежемесячно
5. Метод расчета и другие методологические соображения	

Метод расчета:	Оценки заболеваемости туберкулезом производятся в рамках консультативного и аналитического процесса, проводимого ВОЗ, и публикуются ежегодно. Эти оценки основаны на ежегодных уведомлениях о случаях заболевания, оценке качества и охвата получаемых данных о заболеваемости туберкулезом, национальных обследованиях распространенности заболевания туберкулезом и информации из систем учета естественного движения населения. Оценки заболеваемости для каждой страны производятся с использованием одного или нескольких из следующих подходов в зависимости от имеющихся данных: (i) Уровень заболеваемости = количество уведомлений о случаях заболеваемости/ оценочная доля обнаруженных случаев; (ii) метод двойного охвата (iii) уровень заболеваемости = распространенность заболевания/ продолжительность состояния. Границы неопределенности предоставляются в дополнение к лучшим оценкам.
Комментарии и ограничения:	Показатель уровня заболеваемости туберкулезом был использован на протяжении столетия как основной показатель бремени туберкулеза, совместно с показателем смертности от туберкулеза. Данный показатель позволяет проводить сравнения во времени и между странами. Повышение качества наблюдения за туберкулезом приведет к уменьшению неопределённости в отношении значений показателя
6. Доступность данных и дезагрегация	
Доступность данных и пробелы:	Данные доступны на сайте Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
Уровень дезагрегации:	Показатель дезагрегирован по полу и возрасту (дети и взрослые), по месту проживания (городское/сельское), географических регионов
7. Сопоставимость с международными данными / стандартами	Численность населения, используемая в качестве знаменателя при расчетах, из национальных источников может отличаться от данных из Отдела народонаселения ООН (UNPD). ВОЗ использует оценки населения Отдела народонаселения ООН (UNPD).
8. Ссылки и документация	